

ホルモン療法(内分泌療法)

分類・作用機序・長期服用の支援

1 薬剤の分類マップ

乳がん(エストロゲン)
受容体を遮断・エストロゲン
を減らす

SERM(抗エストロゲン薬) **タモキシフェン** **トレミフェン** SERD **フルベストラント**
アロマトラーゼ阻害薬 **アナストロゾール** **レトロゾール** **エキセメスタン**

性腺機能の抑制
卵巣・精巣のホルモン産生を
止める

LH-RHアゴニスト **リュープロレリン** **ゴセレリン** GnRHアンタゴニスト(前立腺) **デガレリクス**

前立腺がん(アンドロゲン)
受容体を遮断・合成を阻害

抗アンドロゲン薬 **ビカルタミド** **フルタミド**
ARシグナル阻害薬 **エンザルタミド** **アパルタミド** **ダロルタミド** アンドロゲン合成阻害薬 **アビラテロン**

併用薬・その他
効果の増強・骨の保護など

CDK4/6阻害薬(乳がん) **パルボシクリブ** **アベマシクリブ** **骨を守る薬** **デノスマブ** **ゾレドロン酸**
黄体ホルモン(子宮体がん等) **メドロキシプロゲステロン**

☐ 経口薬(保険薬局で交付されることが多い) ☐ 注射薬

2 長期服用中に多い副作用と対処

ほてり・発汗

起こりやすい薬 タモキシフェン、LH-RHアゴニスト、前立腺がんの治療全般

対処・生活の工夫 重ね着で調節、カフェイン・飲酒を控える

受診・連絡の目安
生活に支障が大きい時は相談

関節痛・こわばり

起こりやすい薬 アロマトラーゼ阻害薬

対処・生活の工夫 適度な運動、鎮痛薬の使い方を相談

受診・連絡の目安
やめなくなったら自己中断の前に相談

骨密度低下・骨折

起こりやすい薬 アロマトラーゼ阻害薬、LH-RHアゴニスト、前立腺がんの治療

対処・生活の工夫 骨密度検査、カルシウム・ビタミンD、運動、骨粗鬆症治療薬

受診・連絡の目安
背中や腰の急な痛み、転倒

静脈血栓塞栓症

起こりやすい薬 タモキシフェン、トレミフェン

対処・生活の工夫 長時間同じ姿勢を続けない、水分をとる

受診・連絡の目安
片足の腫れ・痛み、急な息切れは至急

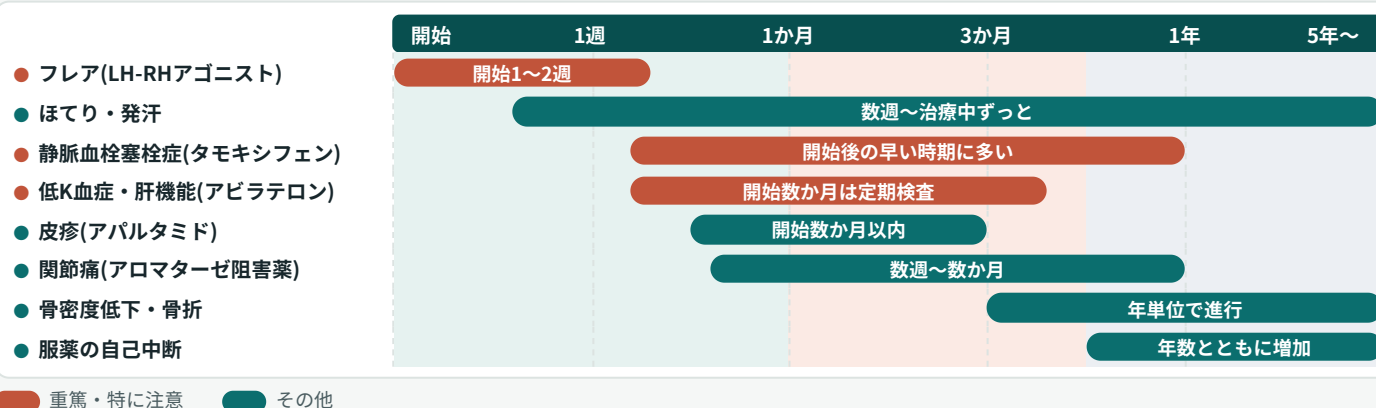
子宮内膜の変化

起こりやすい薬 タモキシフェン

対処・生活の工夫 婦人科での定期的な確認

受診・連絡の目安
不正性器出血は受診

3 副作用の特徴と発現時期



押さえておきたいポイント

1. ホルモン療法はホルモンの産生と受容体を断つ治療。閉経状況と、乳がん・前立腺がんでの使い分けを押さえる
2. 年単位の継続が効果の鍵。ほてり・関節痛・骨の健康への対処で自己中断を防ぐ
3. アビラテロンの空腹時服用、エンザルタミド等の酵素誘導、タモキシフェンとCYP2D6阻害薬に注意